



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica

**“ESTILO DE VIDA Y CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO II DEL CENTRO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA, 2024”**

**PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO EN TECNOLOGÍA
MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA**

Presentado por:

AUTOR: CAMONES CABRERA, JEAN PIERRE GUSTAVO

CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3710-846X>

ASESOR: SALDAÑA OREJÓN, ITALO MOISES

CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7225-5870>

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

1.	EL PROBLEMA.....	1
1.1.	Planteamiento del problema	1
1.2.	Formulación del problema.....	4
1.2.1.	Problema general	4
1.2.2.	Problemas específicos	4
1.3.	Objetivos de la investigación.....	5
1.3.1.	Objetivo general.....	5
1.3.2.	Objetivos específicos	5
1.4.	Justificación de la investigación.....	6
1.4.1.	Teórica	6
1.4.2.	Metodológica	6
1.4.3.	Práctica.....	7
1.5.	Delimitaciones de la investigación.....	7
1.5.1.	Temporal	7
1.5.2.	Espacial	7
1.5.3.	Población o unidad de análisis	8
2.	MARCO TEÓRICO	9
2.1.	Antecedentes	9
2.2.	Bases teóricas	16
2.2.1.	Diabetes.....	16
2.2.2.	Clasificación de la diabetes.....	17
2.2.3.	Estilos de vida	18
2.2.4.	Teorías del estilo de vida	19
2.2.5.	Tipos de estilo de Vida.....	21
2.2.6.	Instrumento para medir el estilo de vida	21
2.2.7.	Dimensiones del estilo de vida.....	22
2.2.8.	Control glucémico.....	23
2.2.9.	Dimensiones del control glucémico	24
2.3.	Formulación de hipótesis.....	25

2.3.1.	Hipótesis general.....	25
2.3.2.	Hipótesis específicas.....	26
3.	METODOLOGÍA.....	27
3.1.	Método de la investigación.....	27
3.2.	Enfoque de la investigación.....	27
3.3.	Tipo de investigación	27
3.4.	Diseño de la investigación.....	28
3.5.	Población, muestra y muestreo.....	28
3.6.	Variables y Operacionalización.....	30
3.6.1.	Variable uno.....	30
3.6.2.	Variable dos	30
3.6.3.	Operacionalización de variables	31
3.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	33
3.7.1.	Técnica.....	33
3.7.2.	Descripción de instrumentos.....	33
3.7.3.	Validación.....	34
3.7.4.	Confiabilidad.....	34
3.8.	Plan de procesamiento y análisis de datos.....	35
3.9.	Aspectos éticos.....	35
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	36
4.1.	Cronograma de actividades	36
4.2.	Presupuesto.....	36
	Referencias Bibliográficas.....	38
	ANEXOS	44
	ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	45
	ANEXO 2: INSTRUMENTOS	47
	ANEXO 3: INSTRUMENTOS	49
	ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO.....	50
	ANEXO 5: TEST DE SIMILITUD.....	52
	ANEXO 6: BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO	53
	ANEXO 7: FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO	54

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estilo de vida puede describirse como un patrón general de existencia que surge de la interrelación entre las circunstancias generales de vida y las conductas individuales, las cuales están influenciadas por el contexto sociocultural y los rasgos personales (1). En este sentido, un estilo de vida poco sano es el origen de múltiples trastornos como la diabetes, la obesidad y el estrés, las cuales están ocasionadas por prácticas como el consumo de sustancias dañinas (alcohol, drogas), una dieta inapropiada, fumar, la falta de actividad física, el vivir apresuradamente y la exposición a agentes contaminantes (2).

Dentro de este contexto, para los pacientes con diabetes mellitus tipo II, adoptar un estilo de vida saludable significa lograr un control glucémico óptimo, lo que implica regular los niveles metabólicos para que se mantengan en los límites normales o ideales (3).

Hoy en día, la diabetes tipo II representa un desafío significativo para la salud pública en las naciones desarrolladas, y su prevalencia ha aumentado rápidamente en los países en vías de desarrollo (4). La creciente incidencia de la diabetes se debe a un estilo de vida deficiente, caracterizado por la falta de tiempo libre, ya sea por compromisos laborales o un ritmo de vida acelerado, que lleva a las personas a consumir alimentos ricos en transgénicos, edulcorantes y sustancias tóxicas. Estos alimentos son perjudiciales para la salud y ofrecen escasos nutrientes, contribuyendo así al aumento de los casos de esta enfermedad (5).

Es por ello que, tras ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo II, es esencial que el paciente mantenga un control glicémico efectivo, el cual abarca una variedad de pruebas tanto sanguíneas como físicas (6). Es conocido que algunos diabéticos no siguen un estilo de vida ni un control metabólico apropiados, por lo que puede llevar a complicaciones de salud a largo plazo, afectación de otros órganos y reducir la esperanza de vida (7). Entre las complicaciones por la que es responsable un control glucémico adecuado se encuentran, las de tipo microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y las de tipo macrovasculares (cerebrovascular y cardiovascular) (8).

Internacionalmente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la diabetes tipo 2 constituye más del 95% de los casos de diabetes, se debe a una utilización ineficiente de la insulina del cuerpo. Este trastorno está asociado principalmente con el exceso de peso y un estilo de vida con poca actividad física. Se calcula que 62 millones de personas en las Américas padecen de diabetes tipo 2, y se proyecta que esta cifra se eleve a 109 millones para el año 2040. Los diabéticos enfrentan un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, sobre todo si no mantienen un control glucémico adecuado. Globalmente, la mortalidad prematura por diabetes aumentó un 5% entre 2000 y 2016. En las Américas, la diabetes fue la 6ta causa principal de muerte en 2019, con aproximadamente 244,084 fallecimientos atribuidos directamente a ella. Un mal estilo de vida con sobrepeso y falta de actividad física son los principales factores de riesgo para la diabetes tipo 2 (9).

A nivel nacional, la diabetes mellitus muestra una mayor prevalencia en la región costera, con un 8.2%, en comparación con la sierra y la selva, donde es del 2.3%. Este fenómeno se atribuye a la falta de adherencia al tratamiento y al inadecuado control metabólico de la enfermedad. Además, los centros de salud, tanto públicos como privados, carecen de un sistema eficiente para la vigilancia y el seguimiento de la diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente 1.3 millones de personas con diabetes representan una prevalencia del 5.9% en el país. Del total de casos registrados entre 2018 y 2021, el 96.7% corresponde a diabetes tipo II (10).

A nivel regional, la Coordinación de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, ha implementado un programa de pruebas de glucosa en 119 centros de salud, desde Barranco hasta Pucusana, para detectar casos de diabetes, enfermedad que afecta a 4423 personas en la región. La mayoría de los casos se encuentran en adultos y ancianos. El tratamiento es gratuito y se enfoca en promover un estilo de vida saludable, incluyendo educación sobre nutrición y ejercicio para los diagnosticados (11).

En relación a lo anteriormente mencionado se plantea el propósito de la presente investigación, la cual es conocer cómo se relacionan el estilo de vida y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el Centro de Salud Santa Fe de Totorita.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación entre estilo de vida y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?
- ¿Cuál es la relación entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?
- ¿Cuál es la relación entre el consumo de cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?
- ¿Cuál es la relación entre la búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?
- ¿Cuál es la relación entre las emociones y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre estilo de vida y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar la relación entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.
- Determinar la relación entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.
- Determinar la relación entre el consumo de cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.
- Determinar la relación entre la búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.
- Determinar la relación entre las emociones, adherencias terapéuticas y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

La justificación teórica de la presente investigación es fomentar el análisis y el debate académico acerca de las diversas facetas relacionadas con el estilo de vida y el control glucémico en pacientes con diabetes tipo II. Se busca cuestionar y comparar la teoría actual con los resultados obtenidos en la población objeto de estudio para crear conocimiento sobre el área de investigación y la problemática planteada. La justificación teórica implica la presentación y explicación de las bases teóricas que sustentan la investigación. Esto implica mostrar cómo el estudio se relaciona con el conocimiento existente en el campo, qué teorías o marcos conceptuales respaldan la investigación y por qué son relevantes para el estudio en cuestión. (41)

1.4.2. Metodológica

Desde una perspectiva metodológica, el estudio aportará al campo de la salud al investigar los estilos de vida y el control glucémico en pacientes con diabetes tipo II por medio de una medición precisa de estas variables, utilizando procedimientos y herramientas validados. Se empleará el cuestionario IMEVID (40), reconocido por su capacidad para evaluar los estilos de vida de los pacientes diabéticos de manera exhaustiva y precisa, lo que permitirán obtener datos confiables para el presente estudio.

Además, para garantizar la rigurosidad de la recopilación de datos, se utilizará una ficha ajustada a los estándares de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para el tratamiento de la diabetes mellitus que permitirá un seguimiento detallado y consistente del control glucémico de los participantes a lo largo del estudio (12). En consecuencia, los resultados obtenidos y los

procedimientos empleados podrán servir como referencia para investigaciones futuras en el área de la diabetes tipo II y el control de estilos de vida relacionados con esta enfermedad.

1.4.3. Práctica

La presente investigación proporcionará una comprensión práctica de los factores que influyen en el estilo de vida y el control glucémico en pacientes con diabetes tipo II, generando conocimientos que puedan ser aplicados directamente en la práctica clínica y en la gestión de la enfermedad, y con ello poder desarrollar estrategias más efectivas para el manejo integral de la diabetes, con el fin de prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes, considerando de manera específicas las características de los pacientes del Centro de Salud Santa Fe de Totorita. La justificación práctica implica explicar cómo los resultados de la investigación pueden ser aplicados para abordar problemas reales, tomar decisiones informadas o contribuir al desarrollo de políticas, programas o prácticas en un determinado campo o área de estudio. (41)

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Temporal

Esta propuesta de investigación se llevará a cabo en los meses de enero – diciembre del año 2024.

1.5.2. Espacial

Esta investigación se llevará a cabo en el centro de salud Santa Fe de Totorita del 2024, ubicada en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Departamento de Lima.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La población de esta investigación estará conformada por los pacientes con diagnóstico clínico de Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el año 2024.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Antecedentes Internacionales

Guamán et al. (13), 2023, en su investigación “Valorar el estilo de vida y su influencia en el control glucémico de pacientes diabéticos tipo 2”. Como metodología utilizaron un estudio descriptivo, con corte transversal, como técnica aplicaron la encuesta, con un cuestionario IMEVID como instrumento, de igual manera como instrumento se empleó una ficha de registro donde recogieron los índices glucémicos, de una muestra de 46 pacientes. De acuerdo a los resultados conseguidos el 54,3% de los pacientes presentaba hábitos de vida poco saludables, el 41,3% tenía un estilo de vida considerado como nocivo, mientras que solo el 4,3% mantenía un estilo de vida beneficioso. Los niveles de azúcar en sangre variaron entre 70 y 305 mg/dL, y se notó que el 89,13% de los pacientes tenía niveles de glucosa superiores a los niveles recomendados. A pesar de que la mitad de los pacientes con un estilo de vida poco saludable mostraron niveles de glucosa por encima de lo sugerido, este hallazgo no tuvo significancia estadística. Así mismo, la correlación entre las variables indicó un resultado no significativo ($r = -0.062$, $p > 0,05$), no obstante, se puntualizó que el signo negativo sugiere un comportamiento inversamente proporcional, de manera que, a mejor calidad del estilo de vida, menor sería el nivel de glucosa basal. Los investigadores llegaron a la conclusión la mayor parte de los pacientes en este estudio mantuvieron un estilo de vida poco saludables y mostraron niveles altos de glucosa en la sangre, lo que incrementa el riesgo de enfrentar complicaciones relacionadas con su padecimiento.

Lara y Herrera (14), 2022, realizaron una investigación en la que tuvieron por objetivo “analizar los estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo II”. Para ello emplearon una metodología cuantitativa, de alcance correlacional y diseño no experimental, con una población de 157 pacientes. Los datos relativos al estilo de vida fueron recolectados a través de una encuesta, según el modelo del Perfil de estilos de vida (PEPS-1) desarrollado por Nola Pender, mientras que el cálculo inferencial se realizó aplicando la prueba de chi-cuadrado en relación al sexo de los pacientes. Se encontró que el 50,96% de los pacientes reportan mantener una nutrición saludable, lo que representa a la mayoría, así como que el 57,96% indica que a veces se ejercita, el 47,77% asume frecuentemente responsabilidad por su salud, el 44,59% maneja el estrés a veces, el 43,31% cuenta frecuentemente con apoyo interpersonal, y el 52,23% se actualiza con información de su enfermedad con frecuencia. Se encontró también una relación significativa entre el sexo del paciente y aquellos que mantienen una nutrición saludable ($p=0.025$), así como entre los que mantienen actualizados sus conocimientos sobre la enfermedad ($p=0.000$), siendo mayor en las mujeres para ambos casos. Se concluyó que, en general, los pacientes mantienen un nivel de vida desfavorable, requiriendo que el personal de salud dedique esfuerzos adicionales para promover la mejora en la salud de este tipo de pacientes.

Irwansyah et al., (15), 2021, tuvieron el objetivo de “Determinar la relación entre la diabetes mellitus y los estilos de vida”. Para ello, la investigación se desarrolló con una metodología cuantitativa, no experimental y transversal, de alcance correlacional, donde se aplicó una encuesta para recolectar datos de ambas variables en una muestra de 198 personas, entre adolescentes y adultos. Con la información recolectada se conformó una base de datos analizada con el programa SPSS, aplicando la prueba de chi-cuadrado con un 95% de

confiabilidad. Los resultados mostraron que el género de los encuestados estaba dominado por mujeres en un 62%. Por su parte, el estilo de vida de los encuestados resultó ser deficiente en términos de salud, ya que la mayoría de ellos no presta atención a su dieta, comiendo más de tres veces al día varios alimentos asociados con altos niveles de colesterol. De manera similar, la mayoría comentó realizar poca actividad física, teniendo rutinas monótonas al pasar largas horas de trabajo sentados y sin practicar deportes en los tiempos libres. Así, el 45% resultó tener un estilo de vida pobre. Por su parte, el análisis inferencial demostró que existe una relación significativa entre ambas variables ($p=0.000$). Se concluyó que los estilos de vida pobres, que más inciden sobre la diabetes, son aquellos que se caracterizan por tener un alto consumo de alimentos con alta densidad energética, con altos contenidos de azúcares y bajos en fibra, y la falta de actividad física.

Vásquez et al., (16), 2019, se plantearon como objetivo “Determinar el impacto del estilo de vida y de sus diferentes componentes en el control glucémico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2”, por lo que el método implementado tuvo un diseño transversal analítico con un alcance correlacional y se llevó a cabo en una unidad de medicina familiar en la Ciudad de México, de agosto a octubre de 2015. Para ello, se incluyó a un total de 330 participantes con diabetes mellitus tipo II, con edades comprendidas entre 20 a 60 años bajo tratamiento farmacológico. Se utilizó el instrumento para medir el estilo de vida en diabéticos (Imevid), y para medir el control glucémico se utilizó hemoglobina glucosilada (HbA1c), considerándose como control glucémico un nivel de Hb1Ac $<7\%$. Para conocer los factores de riesgo asociados a descontrol glucémico se realizó un modelo de regresión logística múltiple, el cual se ajustó por estilo de vida, comorbilidades, tiempo de evolución de la dm2 e índice de masa corporal (IMC).

Como resultados se obtuvo que un 70.3% de los participantes se encontró en el grupo de edad de 51-60 años, 90.6% presentó alguna comorbilidad, destacándose como la más frecuente la hipertensión arterial sistémica, un 48.8% presentó sobrepeso y 14.8% obesidad; 35.8% de los participantes presentaron buen estilo de vida, y 43.9% se encontraba en control glucémico. La mediana de Hb1Ac en pacientes con mal estilo de vida fue de 9% en comparación con el grupo que tenía buen estilo de vida con 6.4%, ($p < 0.001$). El buen estilo de vida es un factor protector para control glucémico con un odds ratio (or) de 0.026. Al respecto, las conclusiones en el estudio fueron que el estilo de vida no saludable fue un factor de riesgo para el descontrol glucémico. Por ello, el estilo de vida, comorbilidades, tiempo de evolución de la diabetes y el IMC explican el 85.3% del descontrol glucémico.

Canché et al., (17), 2018, tuvieron como objetivo “Determinar el efecto de una intervención educativa sobre el estilo de vida, el grado de conocimientos sobre diabetes mellitus 2 y el nivel de la hemoglobina glucosilada”. Con una metodología de diseño cuasi-experimental, aplicando como técnica la encuesta y dos cuestionarios como instrumentos, uno para medir el estilo de vida (IMEVID) y para el grado de conocimiento un cuestionario validado, la muestra fue de 39 pacientes, determinados previa evaluación de los valores de HbA1c. De acuerdo a los resultados se obtuvo que solo el 7,7% de pacientes con un HbA1c controlada y al terminar se obtuvo el 25,6%, otros resultados notables observables fueron los cambios pre y post intervención educativa, para el IMEVID en un inicio fue de 63,15 puntos pasando a 77,41 puntos, el grado de conocimiento paso de presentar 25,73 puntos a cambiar a 79,7 puntos y el HbA1c de un 9,25% a 8,14%. Como conclusión por parte de los investigadores, la intervención

educativa logró mejorar de manera significativa el estilo de vida y el grado de conocimiento ($p < 0.05$), además logró disminuir el nivel de HbA1c.

Antecedentes Nacionales

Floridas (18), 2022, tuvo como objetivo “Determinar el estilo de vida en los pacientes diabéticos del Centro de Salud Bellavista Nanay”. Empleó una metodología de diseño descriptivo, con corte transversal, donde aplicó como técnica la encuesta y dos cuestionarios como instrumentos, en una muestra de 52 pacientes diabéticos. De acuerdo a los resultados obtenidos, los pacientes diabéticos fueron en su mayoría del sexo masculino (59,6%), presentaron estilos de vida no saludables, lo cual se observa en el porcentaje obtenido para las dimensiones, en específico para la dimensión de hábitos nutricionales (51,9%), actividad física (67,3%) y en los hábitos nocivos (53,8%). Como conclusión, el investigador indico que los pacientes diabéticos que son atendidos en el Centro de Salud Bellavista Nanay en Iquitos, tienen un estilo de vida no saludable.

Guevara, (19), 2022 realizo un estudio con el objetivo de “determinar los niveles de control glicémico en pacientes diabéticos atendidos en un centro médico privado en un área urbana de Lima, Perú durante el año 2020”m por lo que realizó un estudio descriptivo de corte transversal, de una muestra de 168 pacientes con edades igual o mayor de 39 años con diagnóstico y en tratamiento de diabetes mellitus por 1 año a más. Entre los resultados encontró que el promedio de hemoglobina glucada en la población estudiada fue de 7.78%, evidenciándose un control inadecuado superando los valores recomendados de control glicémico por la asociación americana de diabetes (2,5%-7%). El sexo con mayor deficiencia en el control

de la enfermedad estuvo representada por el masculino en un 82.1%. El grupo etario con mayor descontrol de la enfermedad fue el adulto intermedio (de 39 a 59 años) en un 62.60%. En conclusión, se constató la existencia de un inadecuado control metabólico en estos pacientes por lo que fue necesario replantear las medidas de salud en todos los niveles de atención.

Guerra y López, (20), 2022, en su investigación que tuvo como objetivo “Determinar la influencia de los estilos de vida en el control glucémico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Centro de Salud 4 de octubre, Socabaya - Arequipa 2022”, empleó como metodología un alcance correlacional de corte transversal y una población de estudio de 46 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta y la observación documental y los instrumentos fueron el instrumento para medir el estilo de vida en diabéticos (IMEVID) y la Ficha de recolección de datos. Los resultados obtenidos mostraron que los estilos de vida fueron regulares en un 80,43%; entre las características sociodemográficas destacaron que 58.70% fueron adultos mayores, 58.70% fueron de sexo femenino; 60.87% tenían pareja y 39.13% tenían instrucción secundaria. Las características clínicas de los pacientes fue de un 73.91% de pacientes con un tiempo de enfermedad menor a 10 años; 73.91% no presentó enfermedad cardiovascular; 63.04% no presentó obesidad y 58.70% no presentó complicaciones. El control glucémico de los pacientes fue adecuado en un 63.04% de casos y los estilos de vida influyeron de forma altamente significativa en el control glucémico de los pacientes con un $X^2=19.0874$ y un valor de $P=0.000$; así también, todas las características sociodemográficas y clínicas influyeron de forma altamente significativa en el control glucémico, alcanzando un valor de obteniendo un $X^2=17.3350$ y

$P=0.000$; $\chi^2=31.0237$ y $P=0.000$, respectivamente. Se concluyó que los estilos de vida influyen significativamente en el control glucémico de los pacientes con diabetes.

Tacza y Ortiz, (21), 2021, elaboraron un estudio cuyo propósito fue “Determinar los estilos de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza, Chupaca-2021”, por lo que su enfoque fue cuantitativo, de tipo básico, con nivel descriptivo de corte transversal o transeccional, con método científico y diseño no experimental. La muestra utilizada fue constituida por 51 pacientes con diagnóstico definitivo de diabetes mellitus tipo 2, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario. De los resultados encontrados, se mostraron que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mantenían estilos de vida saludables, el 62.7% practicaban hábitos saludables favorables, lo que ayudó a controlar esta enfermedad degenerativa, asimismo, el 37.3% estuvo representado por pacientes que tenían estilos de vida no saludables. En conclusión, la diabetes mellitus tipo 2 representó una enfermedad crónica que produjo daños sistémicos, por lo tanto, el mantener estilos de vida saludables evitaría futuras complicaciones.

Raymundo, (8), 2019, en su investigación tuvo como objetivo “Determinar los factores asociados a mal control glicémico en pacientes con diabetes mellitus del Hospital de Huancavelica”, por lo que su diseño fue transversal, retrospectivo, con un alcance correlacional, que evaluó a una muestra de 227 historias clínicas de pacientes con diabetes mellitus atendidos en el 2018. Se denominó adecuado control glicémico a aquel que tenía glucosa en ayunas < 130 mg/dl y hemoglobina glicosilada $< 7\%$. Se realizó un análisis multivariado ajustado a variables clínicas para determinar la asociación de las mismas a mal control glicémico. Los resultados

revelaron que cerca de un 50% tenía más de 60 años, 71% era del sexo femenino y 28% era iletrado. Sólo un 31% tenía índice de masa corporal adecuado y un 48% no tenía obesidad central. Más del 50% tenía un tiempo de diabetes menor a 5 años y un 21% era usuario de insulina. El 71.4% tuvo una inadecuada glicemia en ayunas >130 mg/dL, 80% una hemoglobina glicosilada inadecuada $>7\%$, un 60% un LDL >100 , un 54% triglicéridos >150 mg/dl, un 14% una PAS >140 mm Hg, y un 9% una PAD > 90 mm Hg. Un 82.4 % de los pacientes tuvo un mal control glicémico. En el análisis multivariado ajustado a edad, sexo, instrucción, tiempo de diabetes y obesidad central, se halló que por cada año que aumenta en el tiempo de diabetes el riesgo de mal control glicémico aumenta en 41%; RP 1.41 (IC95% 1.06 – 1.89); y que tener obesidad central eleva el riesgo de un inadecuado control glicémico en 4 veces; RP 4.4 (IC95% 1.23 – 15.6). Se concluyó, que de cada 6 pacientes con diabetes mellitus, 5 tienen mal control glicémico. Este mal control estuvo asociado a mayor tiempo de diabetes y obesidad central.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Diabetes

Según la OMS la diabetes es una afección metabólica de larga duración que se manifiesta por un incremento en los niveles de azúcar en la sangre, lo cual puede resultar en daños significativos a órganos vitales como el corazón, arterias, ojos, riñones y sistema nervioso, debido a una variedad de causas, incluyendo factores genéticos y dietéticos.(22)

Otras definiciones indican que “diabetes mellitus” se refiere a una serie de condiciones unidas por la hiperglucemia. La elevación de la glucosa en sangre puede ser resultado de problemas como el fallo en la producción de insulina o el deterioro de las células Beta del páncreas, encargadas de la producción de insulina, aspectos que son típicos en los distintos tipos

de diabetes mellitus. La reducción en el número de células beta del páncreas puede ser detectada a través de diversos mecanismos, incluyendo cambios epigenéticos, irregularidades genéticas, la existencia de resistencia a la insulina y una variedad de factores ambientales, entre otros aspectos (23). Identificar y categorizar la diabetes son etapas cruciales para el manejo adecuado y para minimizar el riesgo o avance de problemas crónicos. A pesar de que la diabetes puede manifestarse con signos distintivos o condiciones clínicas serias como la cetoacidosis, numerosos adultos con esta enfermedad no presentan síntomas, y su diagnóstico depende de análisis bioquímicos que detectan la hiperglucemia (24).

2.2.2. Clasificación de la diabetes

En el año 1965, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó por vez primera la Diabetes Mellitus, proporcionando una guía que ha sido actualizada en los años 1980, 1985 y 1999. Tradicionalmente, la diabetes se ha dividido en dos categorías principales: Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) y Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2). Sin embargo, actualmente se enfrentan retos para diferenciar entre estos dos tipos debido al incremento de casos de sobrepeso y obesidad en jóvenes con DMT1 y un aumento en la incidencia de DMT2 en la misma población joven, complicando así la correcta clasificación de la diabetes en el momento del diagnóstico (25).

En 2017, la OMS reunió a un equipo de expertos para examinar y actualizar la clasificación de la diabetes, lo que resultó en el lanzamiento de una nueva clasificación para la Diabetes Mellitus en 2019. Dicha clasificación comprende:

- Diabetes Mellitus tipo 1
- Diabetes Mellitus tipo 2

- Formas mixtas de Diabetes: incluyendo la diabetes de evolución lenta mediada inmunológicamente en adultos y la diabetes tipo 2 con tendencia a la cetosis.
- Tipos específicos: como la diabetes monogénica, patologías del páncreas exocrino, desórdenes endocrinos, diabetes inducida por sustancias o medicamentos, infecciones, variantes inusuales de diabetes inmunomediada y otros síndromes genéticos que pueden ir acompañados de diabetes.
- Diabetes sin clasificar
- Hiperglucemia inicialmente identificada en el embarazo: que abarca la diabetes mellitus asociada al embarazo y la diabetes gestacional (25).

2.2.3. Estilos de vida

Un estilo de vida beneficioso, incluye actividad física constante, una alimentación equilibrada, y la abstención del tabaquismo y la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas, esto puede prolongar la esperanza de vida en un rango de 6 a 7 años tanto para hombres como para mujeres (26).

Se ha comprobado que un estilo de vida saludable incrementa el bienestar y la longevidad. Sin embargo, aún no se ha establecido una definición unificada para el comportamiento de vida saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1989, estableció una definición para estilo de vida: “los estilos de vida son patrones de elecciones de comportamiento hechas a partir de las alternativas que están disponibles para las personas de acuerdo con sus circunstancias socioeconómicas y la facilidad con la que pueden elegir unas sobre otras”. Además, la organización identificó el consumo de alcohol y tabaco, la calidad de la dieta y la realización de actividad física como los principales y más importantes

comportamientos de estilo de vida que afectan la salud. Es por esta razón que esta investigación, los comportamientos de estilo de vida incluirán fumar, beber, hacer dieta y hacer ejercicio (27).

2.2.4. Teorías del estilo de vida

Teoría de Nola Pender

La teoría desarrollada por la Dra. Pender en 1975, señala que los factores cognitivos y perceptuales del individuo, influenciados por el entorno, lo personal y lo social, conducen a la adopción de un estilo de vida saludable cuando se presenta una guía clara de acción. El modelo de vida saludable ayuda a discernir aspectos clave en la promoción de la salud e integra descubrimientos investigativos que apoyan la formulación de hipótesis verificables. Dicha teoría se encuentra en constante evolución y refinamiento para mejorar su explicación sobre cómo ciertos factores impactan en el cambio de comportamientos relacionados con la salud. Este modelo promueve la educación sobre el autocuidado y la adopción de un estilo de vida sano. Las principales características de dicho modelo son las siguientes:

- Promoción de la salud: se entiende como la conducta impulsada por el anhelo de mejorar el bienestar y potenciar las capacidades de salud del ser humano, representando una estrategia hacia el bienestar.
- Protección de la salud o prevención de enfermedades: se refiere al comportamiento inspirado por el deseo de prevenir activamente las enfermedades, detectarlas de manera precoz o mantener el funcionamiento a pesar de las restricciones que estas impongan.
- Características y vivencias personales: incluyen el comportamiento pasado y los factores individuales.

- Cogniciones y emociones asociadas al comportamiento: abarcan los beneficios esperados de la acción, los obstáculos anticipados para actuar, la confianza en la propia capacidad, los sentimientos vinculados a la actividad, las influencias de otras personas y las circunstancias del entorno.
- Resultados del comportamiento: comprenden la adhesión a un plan de acción, las necesidades y preferencias competitivas actuales, y las acciones que fomentan la salud.

Teoría de Elliott Delbert

De acuerdo con Elliott Delbert y su teoría desarrollada en 1993, el estilo de vida saludable se entiende como un patrón de comportamientos relacionado con la salud que se llevan a cabo de un modo relativamente estable. Para Elliott Los aspectos esenciales de un estilo de vida saludable se pueden resumir en cuatro puntos clave (28):

- Es de naturaleza conductual y se puede observar directamente. Aunque las actitudes, valores y motivaciones no son parte de él, pueden influir en su formación.
- Las conductas que lo definen deben ser sostenidas a lo largo del tiempo. El término estilo de vida implica prácticas con cierta duración, ya que refleja un patrón de vida regular. Por ejemplo, haber fumado tabaco ocasionalmente no indica un estilo de vida riesgoso para la salud. Del mismo modo, si se ha dejado una conducta, está ya no se considera parte del estilo de vida.
- El estilo de vida representa combinaciones de comportamientos que se manifiestan de manera constante. Se ve como un conjunto de acciones coherentes y organizadas en respuesta a las distintas circunstancias de cada individuo o grupo.

- Aunque el concepto de estilo de vida no sugiere una única razón para todas las conductas que lo integran, se espera que existan algunas causas comunes entre ellas (28).

2.2.5. Tipos de estilo de Vida

Pueden existir varios estilos de vida, sin embargo, en esta investigación se detallarán los siguientes:

- Estilo de vida saludable: se refiere a la serie de acciones y rutinas diarias que las personas llevan a cabo con el fin de mantener una salud física y mental ideal. Esto conduce a la realización de objetivos, el aumento de la confianza en uno mismo y la mejora de la percepción personal, lo cual también es notado por otros. Asimismo, adoptar un estilo de vida saludable se asocia con la disminución de riesgos para la salud. (29).
- Estilos de vida no saludable: un estilo de vida no saludable engloba aquellos hábitos, ya sean activos o inactivos, que deterioran el bienestar físico y psicológico, llevando a consecuencias adversas en la calidad de vida. Las prácticas dañinas para la salud incluyen el consumo de sustancias perjudiciales, el uso de tabaco, la falta de actividad física y la exposición a agentes contaminantes, entre otras. (30).

2.2.6. Instrumento para medir el estilo de vida

Relacionado al control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el estilo de vida es determinado con el uso del cuestionario o instrumento de Medición de Estilo de Vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (IMEVID) y según la puntuación se divide en tres: Desfavorable (<60 puntos), poco favorable (60 a 80 puntos) y favorable (>80 puntos) (23). El cuestionario IMEVID será el instrumento empleado en este estudio; es una herramienta diseñada

para evaluar el estilo de vida en pacientes con diabetes, la cual ha sido previamente validada y normalizada, y ya ha sido aplicada en múltiples estudios en Perú (7).

2.2.7. Dimensiones del estilo de vida

Se estructura en 7 dimensiones para analizar el estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, entre ellas las siguientes:

- Nutrición, que busca valorar una dieta balanceada y adecuada para el paciente, y la actividad física, que mide la frecuencia y tipo de movimiento corporal, como caminar o ejercitarse.
- Cigarro y alcohol: son comportamientos perjudiciales para la salud, y se identifican como factores de riesgo que pueden agravar las complicaciones en pacientes con diabetes.
- Ejercicio: es crucial que los pacientes diabéticos estén bien informados sobre su condición y los cuidados necesarios.
- Información sobre la diabetes: esta dimensión es importante porque todo paciente diabético debe tener conocimiento sobre las características y cuidado que su enfermedad necesita.
- Emociones: estas permiten analizar reacciones fisiológicas inmediatas.
- Adherencia terapéutica: es un aspecto crítico, ya que es sabido que muchos pacientes no siguen adecuadamente las prescripciones médicas, lo cual es especialmente dañino en enfermedades crónicas donde el tratamiento médico es esencial para controlar los niveles y mantener la salud. (7).

2.2.8. Control glucémico

El control glucémico es definido como todas aquellas medidas que van a facilitar el mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad. Para el paciente con diabetes tipo 2, el control glucémico principalmente se centra en la determinación de tres parámetros: el primero, representado por la hemoglobina glucosilada (A1c), el segundo por la glucosa plasmática en ayunas (FPG) y el tercero, por la glucosa postprandial (GPP). En la actualidad, la hemoglobina glucosilada es considerada el esquema de referencia para que se evalúe el control glucémico de un paciente diabético, ya que posee una experiencia larga disponible acerca de la reducción del riesgo de complicaciones crónicas (31).

Ahora bien, la hiperglucemia define a la diabetes y el control glucémico es elemental para su manejo, encontrándose asociado con un estado de bienestar y funcionalidad del paciente con diabetes mellitus tipo 2. La ADA recomienda ejecutar la medición del control glucémico al menos dos veces anualmente para aquellos que se encuentran en control, y cada tres meses para aquellos pacientes con descontrol glucémico. En pacientes que padecen de complicaciones macrovasculares o microvasculares y con comorbilidades como la hipertensión arterial y la obesidad, la meta es mantener el control glucémico con un nivel inferior al 8% (32).

La presencia de obesidad en personas con diabetes aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. A menudo otros factores de riesgo cardiovascular en éstos pacientes son la hipertensión arterial y dislipidemias para lo que requieren una mayor vigilancia de éstos aspectos. Ensayos controlados de reconocida trascendencia, han mostrado que un mejor control glucémico se asocia con la disminución en el desarrollo y progresión de complicaciones micro y macrovasculares. El control glucémico se refiere a un resultado en salud, es un estado de bienestar o integridad estructural o funcional, por lo que la ejecución de actividades de auto-

manejo tendrá como resultado el control glucémico verificable según los estándares expuestos por la ADA (33).

2.2.9. Dimensiones del control glucémico

De acuerdo a lo expuesto por la Asociación Americana de Diabetes (ADA), el control glucémico puede ejercerse a través de las siguientes pruebas:

- **Hemoglobina glucosilada (HbA1c):** prueba que calcula el nivel de glucosa (azúcar) en sangre promedio durante los últimos dos o tres meses. Representa una proteína que se conjuga desde las reacciones bioquímicas de la hemoglobina y distintos azúcares y se practica mediante un examen de sangre específicamente para la diabetes tipo 2 y prediabetes, donde su resultado es revelado en porcentajes; por lo que se indica que, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es su nivel de azúcar en la sangre. Por ello, un nivel de HbA1c normal es menor al 5,7%, mientras que, para la prediabetes, se ubica entre 5,7 a 6,4%. Tener prediabetes representa es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, motivo por el que se indica, que las personas con prediabetes pueden verse en la necesidad de repetir las pruebas anualmente. Por último, para la diabetes tipo 2, el nivel de HbA1c se ubica por encima del 6,5% (12).
- **Glucosa plasmática en ayunas (FPA):** es una prueba que va a permitir medir los niveles de glucosa (azúcar) en sangre en ayunas. Para mantenerse en ayunas, el paciente no debe comer ni beber nada (excepto agua) por lo menos unas ocho horas antes de la prueba, la cual por lo general es realizada a primera hora de la mañana, antes del desayuno. Esta prueba igualmente puede ser utilizada para que se examine a un paciente en busca de diabetes, pues es muy posible que la hiperglucemia y la diabetes no causen síntomas en

las primeras etapas. Esta prueba es la más común realizada para la detección de diabetes, comenzando normalmente a la edad de 35 años, destacando que, si el paciente no tiene otros factores de riesgo, debe hacerse una prueba cada 3 años, y, en algunos casos, con más frecuencia si el peso de dicho paciente va en aumento. Por ello, un nivel normal de glucosa en ayunas es menor a 100 mg/dL, mientras que, para la prediabetes, con una glucemia de ayuno alterada los valores se ubican entre 100 - 125 mg/dL. Finalmente para la diabetes, los niveles de glucosa se encuentran por encima de 126 mg/dL (12).

- **Glucosa postprandial (GPP):** prueba con una duración de dos horas la cual va a permitir analizar los niveles de glucosa (azúcar) en sangre antes y dos horas después de algún alimento o bebida dulce especial. Esta va a indicar la forma en que el cuerpo va a procesar el azúcar. La hiperglucemia postprandial (HPP) es un fenómeno muy frecuente en personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2, que puede producirse incluso cuando el control metabólico general parezca adecuado tras su evaluación mediante la hemoglobina glucosilada (HbA1c). Por ello, un nivel normal de glucosa postprandial es menor a 140 mg/dL, mientras que para la prediabetes con una intolerancia a la glucosa (IGA) los valores se ubican entre 140 -199 mg/dL. Finalmente para la diabetes, los niveles de glucosa postprandial los niveles se encuentran por encima de 200 mg/dL (12).

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

- Existe una relación significativa entre el estilo de vida y control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024.

2.3.2. Hipótesis específicas

- Existe relación entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024
- Existe relación entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024
- Existe relación entre el consumo de cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024
- Existe relación entre la búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024
- Existe relación entre las emociones y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de la investigación

El método que se utilizará en el presente estudio será hipotético – deductivo, el cual consiste en la observación de un fenómeno o problemática, para la creación de una hipótesis explicativa, la deducción de resultados esperados y su posterior verificación empírica para validar o descartar la hipótesis planteada (34)

3.2. Enfoque de la investigación

Para la presente investigación el enfoque será cuantitativo, siendo aquel que se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para validar hipótesis y el logro de los objetivos (35). En base a ello, el estudio estará apoyándose en encuestas de amplias muestras poblacionales, cuyos resultados serán analizados de forma estadística.

3.3. Tipo de investigación

El presente estudio representa una investigación de tipo básica, la cual es aquella que se centra en enriquecer y expandir el conocimiento científico sobre la realidad sin buscar aplicaciones prácticas inmediatas. Se enfoca en examinar y refinar las teorías científicas existentes (34). En este caso, se profundizará el tema de la relación de las variables del estudio en la población objetivo.

3.4. Diseño de la investigación

El diseño de investigación será de tipo no experimental, la cual es aquella que se caracteriza por el estudio de fenómenos tal y como ocurren en su contexto real, sin alterar o controlar las variables involucradas (35). En cuanto al alcance, este será correlacional, siendo aquel que se concentra en describir el vínculo entre distintas categorías, conceptos o variables en un momento específico (35). De acuerdo con esto, será también de corte transversal, que es el tipo de investigación que estudia las variables en un periodo determinado de tiempo (34).

3.5. Población, muestra y muestreo

La población se define como el grupo completo de elementos que cumplen con ciertos criterios establecidos para la investigación (35). En este sentido, la población estará constituida por pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que se atienden en el Centro de Salud Santa Fe de Totorita durante el año 2024.

Por su parte, se entiende como muestra es un subgrupo seleccionado de la población que refleja fielmente sus características, y se utiliza con el propósito de deducir las cualidades de la población completa (34). En base a ello, y siendo el presente estudio de corte retrospectivo, se calculará el tamaño de muestra requerida para garantizar la representatividad de los datos, haciendo uso de la siguiente formula:

$$n = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

Dónde:

n= tamaño de la muestra.

Z = nivel de confianza.

e= error de estimación

p = probabilidad que ocurra

q = probabilidad en contra

$$n = \frac{1.96^2 * 0.50 * 0.50}{0.05^2} = 104$$

El muestreo que se realizará será probabilístico de tipo aleatorio, definido como aquel donde cada sujeto que cumpla los criterios de inclusión tiene igual probabilidad de ser considerado parte de la muestra (36). En este sentido, se recolectará información de los pacientes atendidos en el centro médico hasta cumplir con el tamaño de la muestra determinada.

3.5.1 Criterios de inclusión:

- Pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
- Pacientes que firmarán el consentimiento informado para participar de la investigación.
- Pacientes que cuenten con seguro integral de salud y con todos los datos en sus historias clínicas.

3.5.2 Criterios de exclusión:

- Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 o diabetes gestacional.
- Pacientes que no desean firmar el consentimiento informado.

- Pacientes que no cuenten con seguro integral de salud y que no tengan completos los datos en sus historias clínicas.

3.6. Variables y Operacionalización

3.6.1. Variable uno

- Estilo de vida

3.6.2. Variable dos

- Control glucémico

3.6.3. Operacionalización de variables

Tabla 1. Operacionalización de las Variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Estilo de vida	Los estilos de vida son patrones de elecciones de comportamiento hechas a partir de las alternativas que están disponibles para las personas de acuerdo con sus circunstancias socioeconómicas y la facilidad con la que pueden elegir unas sobre otras	Se obtendrán los resultados mediante una encuesta llamada IMEVID que se le realizaran a los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024	Nutrición	Tipo y frecuencia de alimentos consumidos	Nominal	Favorable Mayor a 80 puntos Poco favorable Entre 60 – 80 puntos Desfavorable Menor a 60 puntos
			Ejercicio	Frecuencia de realización de actividad física	Nominal	
			Cigarro	Frecuencia del consumo de cigarro	Nominal	
			Alcohol	Frecuencia del consumo de alcohol	Nominal	
			Información de diabetes	Frecuencia de búsqueda de información	Nominal	
			Emociones	Frecuencia de emociones negativas	Nominal	
			Adherencias terapéuticas	Frecuencia de acciones para adherirse al plan terapéutico	Nominal	

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Control Glucémico	Medidas que van a facilitar el mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad (31).	Determinación de la glucosa en las historias clínicas de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024	Hemoglobina glucosilada (A1c)	< 7%	Ordinal	En control
						En descontrol
			Glucosa plasmática en ayunas (FPA)	80 – 130 mg/dl	Ordinal	En control
						En descontrol

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

Como técnica para la recolección de datos de la variable estilo de vida se utilizará la encuesta IMEVID. En cuanto a la variable control glucémico se empleará la observación documental, involucrara examinar y anotar los resultados de las historia clínicas de los pacientes en el estudio en una ficha de recolección de datos (anexo 3).

3.7.2. Descripción de instrumentos

Como instrumento para la recolección de datos de la variable estilo de vida se usará el cuestionario IMEVID, conformado por 25 preguntas, contando con una calificación global entre 0 a 100 puntos, además las calificaciones para cada pregunta pueden ser 0, 2 y 4 para tres opciones que se presentan como respuestas. El mismo cuenta con 7 dimensiones, las cuales son: Nutrición (preguntas 1-9), Actividad física (preguntas 10-12), Consumo de tabaco (preguntas 13-14), Consumo de alcohol (preguntas 15-16), Información de diabetes (preguntas 17-18), Emociones (preguntas 19-21), Adherencia terapéutica (22-25). Como resultado final de este instrumento se tiene los siguientes valores: estilo de vida desfavorable (menor a 60 puntos), estilo de vida poco favorable (60 a 80 puntos) y estilo de vida favorable (mayor a 80 puntos) (37).

Como instrumento para recolección de información perteneciente a la variable control glucémico, se empleará una ficha de registro anotando los resultados de glucosa plasmática en ayunas y hemoglobina glucosilada. Dicha ficha será adaptada según los estándares utilizados para la atención médica en pacientes que desarrollan diabetes mellitus tipo II de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), será utilizado como una guía de interpretación diagnóstica para el control glucémico. De esta manera, la variable se clasificará como “En

control” cuando se observen valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) $< 5.7 \%$ o glucosa plasmática en ayunas (FPA) $< 100 \text{ mg/dL}$. Se considerará como “En descontrol”, cuando se observen valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) $\geq 6.5\%$ o glucosa plasmática en ayunas (FPA) $\geq 126 \text{ mg/dL}$.

3.7.3. Validación

Con respecto a la validación del cuestionario IMEVID, la encuesta ya ha sido validada en el año 2003 en el estudio realizado por López, Rodríguez y Munguía (37), pasando por la evaluación de 16 profesionales de la salud, especialistas, de manera independiente, cada profesional debía tener más de 5 años atendiendo pacientes con diabetes mellitus.

3.7.4. Confiabilidad

En cuanto a la confiabilidad de dicho instrumento, esta se estimó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, necesitando un coeficiente de 0.70 o superior (35). Los resultados se presentan en el Anexo 7.

Finalmente, se implementarán los niveles de control de calidad del equipo de hemoglobina glucosilada que la misma casa comercial viene a pasarlo midiendo la precisión, además del control de calidad interno con los sueros normal y patológico de la marca BioSystems midiendo la precisión y por el control externo que se realiza con la marca ESfEQA midiendo la exactitud con otros laboratorios de DIRIS LIMA CENTRO el cual se colocan los valores en un formato al Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad (IGCC).

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Tras completar la recopilación de datos, se procederá a registrar y codificar esta información en un archivo para crear una base de datos en Microsoft Excel. Posteriormente, se aplicará la estadística descriptiva para determinar las frecuencias de las respuestas, que se expondrán mediante gráficos y tablas cruzadas, según las categorías de medición de cada variable.

De igual manera, se hará uso de estadística inferencial para establecer las relaciones entre las variables estudiadas empleando la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, que se llevará a cabo con el software SPSS versión 25 considerando un nivel de significancia del 5% ($p = 0.05$), de esta manera, si el p-valor obtenido es menor a 0.05, existe una dependencia entre las variables, y se aceptará que están relacionadas.

3.9. Aspectos éticos

Para los aspectos éticos se tendrá en cuenta Principios de Bioéticos de Belmont (38), descritos a continuación:

Esta investigación puede ser de beneficio para los participantes, al conocer su control glucémico y también reconocer el estilo de vida que están llevando. A cada persona dentro de la población se le va tratar como un ser autónomo y con libertad de actuación. Se evitará exponer a los pacientes a situaciones de riesgo y el estudio se someterá a una revisión del comité de ética de la universidad Norbert Wiener.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades

Tabla 2. Cronograma de actividades

Actividades	Meses											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Planificación												
Búsqueda de información												
Elaboración del proyecto												
Presentación a autoridades												
Aprobación del proyecto												
Sustentación del proyecto												
Ejecución												
Estudio piloto												
Validación de instrumentos												
Recolección de datos												
Digitación de datos												
Análisis de datos												
Procesamiento de datos												
Elaboración del informe												
Presentación del informe												
Aprobación												
Sustentación de la tesis												
Publicación												

4.2. Presupuesto

En la tabla 3.

Tabla 3. Presupuesto

Descripción	Cantidad	Costos Unitarios	Costo total
Recursos humanos			
Ayudante para recolección de datos	1	375.00	375.00
Bienes e insumos			
Computador	1	1,999.00	1,999.00
Papel bond A4	2	25.00	50.00
Folders	10	4.00	40.00
Lápiz	1	30.00	30.00
Servicios			
Asesoría especializada	1	500.00	500.00
Movilidad diversa	20	15.00	300.00
Internet	8	95.00	760.00
Fotocopias, impresiones	100	0.50	50.00
Total			4,104.00

Referencias Bibliográficas

1. Salud Gobierno de México. gob.mx. 2021 [citado 1 de abril de 2024]. Activa tu modo saludable. Disponible en: <http://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/activa-tu-modo-saludable>
2. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Atención Primaria. 2021 [citado 1 de abril de 2024]. Estilos de Vida. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/ciudadanos/estilos-vida>
3. Farías B, Bardales D. Conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 2 y adherencia al tratamiento en pacientes del hospital Reátegui de Piura, Perú. Acta Médica Peruana. enero de 2021;38(1):34-41.
4. Mallma Y, Pérez de Velazco C. Estilo de vida en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II en un conjunto habitacional en Lima. Revista Científica Ágora. 31 de diciembre de 2021;8(2):20-6.
5. Rico R, Juárez A, Sánchez M, Muñoz L. Nivel de Conocimientos, Estilos de Vida y Control Glicémico en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Ene [Internet]. 2018 [citado 1 de abril de 2024];12(1). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2018000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
6. Domínguez P. Control Metabólico en Pacientes Diabéticos Tipo 2: grado de Control y nivel de Conocimientos (Estudio AZUER). Revista Clínica de Medicina de Familia. 2011;4(1):32-41.

7. Asenjo J. Relación entre estilo de vida y control metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de Chota, Perú. *Revista Médica Herediana*. 2020;31(2):101-7.

8. Raymundo K. Factores asociados a mal control glicémico en pacientes con diabetes mellitus del Hospital de Huancavelica [Internet] [Tesis de Pregrado]. [Huancayo - Perú]: Universidad Peruana Los Andes; 2019. Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/1024>

9. OPS. Diabetes - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2023 [citado 2 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>

10. MINSA. CDC Perú: El 96,5% de la población diagnosticada con diabetes tiene diabetes tipo 2 [Internet]. CDC MINSA. 2022 [citado 1 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-el-965-de-la-poblacion-diagnosticada-con-diabetes-tiene-diabetes-tipo-2/>

11. Plataforma digital única del Estado Peruano. Establecimientos de salud de Lima sur realizan descarte de diabetes y brindan tratamiento gratuito [Internet]. 2022 [citado 2 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/670338-establecimientos-de-salud-de-lima-sur-realizan-descarte-de-diabetes-y-brindan-tratamiento-gratuito>

12. American Diabetes Association (ADA). Diagnóstico [Internet]. 2024. Disponible en: [https://diabetes.org/espanol/diagnostico#:~:text=graves%20de%20diabetes.-,La%20diabetes%20se%20diagnostica%20cuando%20el%20nivel%20de%20glucosa%20\(az%C3%BAcar,igual%20a%20200%20mg%2Fdl](https://diabetes.org/espanol/diagnostico#:~:text=graves%20de%20diabetes.-,La%20diabetes%20se%20diagnostica%20cuando%20el%20nivel%20de%20glucosa%20(az%C3%BAcar,igual%20a%20200%20mg%2Fdl)

13. Guamán S, Cedeño M, Vélez P, Cantos S. Estilo de vida y su influencia en el control glucémico de pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en un hospital público de Ecuador. *Anatomía Digital*. 4 de agosto de 2023;6(3.1):33-43.
14. Lara K, Herrera V. Estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus tipos 2 en tiempos de pandemia COVID- 19. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*. 15 de diciembre de 2022;3(8):250-8.
15. Irwansyah I, Syarief I, Bohari B. The RelationsThe Relationship between Lifestyle with the Risk of Diabetes Mellitus in Staff and Lecturers of Universitas Megarezky. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. 2 de marzo de 2021;9(E):198-202.
16. Vásquez A, Velázquez L, Navarro S. Impacto del estilo de vida en el descontrol glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Aten Fam*. 2019;26(1):18-22.
17. Canché D, Zapata R, Rubio H, Cámara R. Efecto de una intervención educativa sobre el estilo de vida, el control glucémico y el conocimiento de la enfermedad, en personas con diabetes mellitus tipo 2, Bokobá, Yucatán. *Revista biomédica*. 2019;30(1):3-11.
18. Floridas R. Estilos de vida en pacientes diabéticos del C.S Bellavista Nanay, 2020 [Internet] [Tesis Pregrado]. [Perú]: Universidad Científica del Perú; 2021 [citado 1 de abril de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/1700>
19. Guevara A. Niveles de control glicémico en pacientes diabéticos a través de la hemoglobina glucada en un área urbana de Villa el Salvador, Lima, Perú, 2020-2021. *Rev Peru Investig Salud*. 2022;6(1):29-32.

20. Guerra J, López P. Influencia de los estilos de vida, características sociodemográficas y clínicas en el control glucémico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Centro de Salud 4 de Octubre, Socabaya - Arequipa 2022 [Internet] [Tesis de Pregrado]. [Arequipa - Perú]: Universidad Católica de Santa María; 2022. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/efd10b2b-b248-458f-b13d-81ae5f382423>

21. Tacza A, Ortiz K. Estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza, Chupaca-2021 [Internet] [Tesis de Pregrado]. [Huancayo - Perú]: Universidad Continental; 2021. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10599/1/IV_FCS_504_TE_Tacza_Ortiz_2021.pdf

22. OMS. Diabetes - Organización Mundial de la Salud [Internet]. [citado 5 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/health-topics/diabetes>

23. Colagiuri S. Definition and Classification of Diabetes and Prediabetes and Emerging Data on Phenotypes. *Endocrinol Metab Clin North Am.* septiembre de 2021;50(3):319-36.

24. Anthony N, Lenclume V, Fianu A, Moullec NL, Debussche X, Gérardin P, et al. Association between prediabetes definition and progression to diabetes: The REDIA follow-up study. *Diabetes Epidemiology and Management.* 1 de julio de 2021;3:100024.

25. OMS. Classification of diabetes mellitus [Internet]. 2019 [citado 5 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/publications-detail-redirect/classification-of-diabetes-mellitus>

26. Liang S, Wang N, Wang Y, Wang M, Zhao X, Yang M, et al. Polygenic risk for termination of the «healthspan» and its interactions with lifestyle factors: A prospective cohort study based on 288,359 participants. *Maturitas*. septiembre de 2023;175:107786.
27. Cheng T, Zhang B, Luo L, Guo J. The influence of healthy lifestyle behaviors on cognitive function among older Chinese adults across age and gender: Evidence from panel data. *Arch Gerontol Geriatr*. septiembre de 2023;112:105040.
28. Elliott D. Health-enhancing and health-compromising lifestyles. Oxford University Press; 1993. 421 p.
29. Arce S. School Nurses. 2019 [citado 5 de abril de 2024]. ¿Qué es un estilo de vida saludable y cómo conseguir adoptarlo? Disponible en: <https://schoolnurses.es/que-es-un-estilo-de-vida-saludable-y-como-conseguir-adoptarlo/>
30. García J, Garza R, Cabello M. Dimensiones de los estilos de vida saludable durante el confinamiento por COVID-19 en población mexicana. *PROSPECTIVA Revista de Trabajo Social e Intervención Social*. 1 de julio de 2022;249-70.
31. Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). Guías ALAD sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con medicina basada en evidencia edición 2019 [Internet]. 2019. Disponible en: https://revistaalad.com/guias/5600AX191_guias_alad_2019.pdf
32. American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2017. *Diabetes Care*. 2017;40(1):S1-135.

33. Rodríguez Y, Gallegos E, Gutiérrez J, Alarcón N. Teoría de auto-manejo y control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. *Journal Health NPEPS*. 2017;2(2):444-56.
34. Palomino J, Zevallos G, Peña J. Metodología de la investigación. Guía para elaborar un proyecto en salud y educación. San Marcos; 2019.
35. Hernández R, Mendoza P. Metodología de la investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 1era ed. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.; 2018. 751 p.
36. Arias F. El proyecto de investigación. 7ma Edición. Episteme; 2016.
37. López J, Ariza C, Rodríguez J, Munguía C. Construcción y validación inicial de un instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Salud Pública de México*. agosto de 2003;45(4):259-67.
38. Observatori de Bioètica i Dret. El Informe Belmont [Internet]. 1979. Disponible en: <https://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título de la investigación: Estilo de vida y control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024.

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general ¿Cuál es la relación entre estilo de vida y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024? Problemas específicos ¿Cuál es la relación entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024? ¿Cuál es la relación entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024? ¿Cuál es la relación entre el consumo de cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024? ¿Cuál es la relación entre la	Objetivo general Determinar la relación entre estilo de vida y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024. Objetivos específicos Determinar la relación entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Determinar la relación entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Determinar la relación entre el consumo cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Determinar la relación entre la	Hipótesis general Existe una relación significativa entre el estilo de vida y control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita, 2024. Hipótesis específicas Existe una relación significativa entre la nutrición y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Existe una relación significativa entre el ejercicio y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Existe una relación significativa entre el consumo cigarro, alcohol y el control glucémico en pacientes con diabetes	Variable uno Estilo de Vida Dimensiones: Tipo de nutrición Frecuencia de ejercicio Consumo de cigarro Consumo de alcohol Información de diabetes Emociones Adherencia terapéutica Variable dos Control Glucémico Dimensiones: Hemoglobina glucosilada (A1c) Glucosa plasmática en ayunas (FPA)	Tipo de investigación Básica Método Hipotético – deductivo Diseño de la investigación Enfoque cuantitativo Diseño no experimental Alcance correlacional Corte transversal Población Constituido por el total de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Muestra El tamaño de la muestra estará constituido por el total de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que se atienden en el centro de salud Santa Fe de Totorita.

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024? ¿Cuál es la relación entre las emociones y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024?	búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Determinar la relación entre las emociones y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.	mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Existe una relación significativa entre la búsqueda de información sobre diabetes y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024. Existe una relación significativa entre las emociones y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Centro de Salud Santa Fe de Totorita en el 2024.		

ANEXO 2: INSTRUMENTOS

1. CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA (IMEVID)

INSTRUCCIONES: sírvase leer cuidadosamente las preguntas, marque la opción que usted considere en relación a su estilo de vida durante los últimos tres meses.

PREGUNTAS	Opciones de respuesta		
NUTRICIÓN			
1. ¿Con qué frecuencia come frutas?	Todos los días de la semana	Algunos días	Casi nunca
2. ¿Con qué frecuencia come verduras?	Todos los días de la semana	Algunos días	Casi nunca
3. ¿Cuántas piezas de pan come al día?	0 a 1	2	3 o más
4. ¿Cuántas piezas de tortilla come al día?	0 a 3	4 a 6	7 o más
5. ¿Agrega azúcar a sus alimentos o bebidas?	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente
6. ¿Agregas a los alimentos cuando lo está comiendo?	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre
7. ¿Come alimentos entre comidas?	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente
8. ¿Come alimentos fuera de casa?	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente
9. ¿Cuándo termina de comer la cantidad servida inicialmente, pide que le sirvan más?	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre
EJERCICIO			
10. ¿Con qué frecuencia hace al menos 30 minutos de ejercicio? (camina rápido, corre o algún otro)	4 o más veces por semana	1 a 3 veces por semana	Casi nunca
11. ¿Se mantiene ocupado fuera de sus actividades habituales de trabajo?	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca
12. ¿Qué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre?	Salir de casa	Trabajos en casa	Ver televisión
CIGARRO			
13. ¿Fuma?	No fumo	Algunas veces	Fuma a diario
14. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?	Ninguno	1 a 5	6 o más

ALCOHOL			
15. ¿Bebe alcohol?	Nunca	Rara vez	1 vez por semana
16. ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma en cada ocasión?	Ninguna	1 a 2	3 o más
INFORMACIÓN			
17. ¿A cuántas charlas para personas con DM ha asistido?	4 o más	1 a 3	Ninguna
18. ¿Trata de obtener información sobre la DM?	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca
EMOCIONES			
19. ¿Se enoja con facilidad?	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre
20. ¿Se siente triste?	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre
21. ¿Tiene pensamientos pesimistas sobre su futuro?	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre
ADHERENCIA TERAPÉUTICA			
22. ¿Hace su máxima esfuerzo para tener controlada su DM?	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca
23. ¿Sigue dieta para paciente diabético?	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca
24. ¿Olvida tomar sus medicamentos para la DM o aplicarse su insulina?	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente
25. ¿Sigue las instrucciones médicas que se le indican para su cuidado?	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca

ANEXO 3: INSTRUMENTOS

2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Datos Personales:

Nombre de paciente:

Edad: Género: Estado civil:

Grado de Instrucción.....Tiempo de enfermedad:

Historia clínica:

Datos del Control Glucémico del paciente:

Tipo de prueba realizada	Valores del paciente con DM tipo 2	En control	En descontrol
Hemoglobina glucosilada (HbA1c) :			
Glucosa plasmática en ayunas (mg/dl):			

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Instituciones: Universidad Privada Norbert Wiener

Investigador: Jean Pierre Gustavo Camones Cabrera

Título: “ESTILO DE VIDA Y CONTROL GLUCEMICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II DEL CENTRO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA, 2024”

Propósito del estudio

Lo invitamos a participar en un estudio llamado: “Estilo de vida y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo II del centro de salud Santa Fe de Totorita, 2024”. Este es un estudio desarrollado por un investigador de la Universidad Privada Norbert Wiener. El propósito de este estudio es determinar la relación del estilo de vida y el control glucémico en los pacientes con diabetes mellitus tipo II. Su ejecución ayudará al reconocimiento del estilo de vida de los pacientes, si es saludable o no, además de la determinación del control glucémico.

Procedimientos

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:

- ☐ Encuesta sobre el Estilo de Vida (IMEVID)
- ☐ Determinación del Control Glucémico

La encuesta puede demorar unos 25 minutos y los resultados se le entregarán a usted en forma individual o almacenarán respetando la confidencialidad y el anonimato.

Riesgos

Su participación en el estudio, no significará ningún riesgo porque en todo momento se velará por su integridad y seguridad, el investigador al ser profesional de la salud está completamente capacitado para la atención de los pacientes.

Beneficios

Usted se beneficiará, ya que podrá conocer cuál es el estilo de vida que está llevando en la actualidad, de acuerdo a este resultado podrá recibir consejos por parte del investigador para su mejora de ser necesario. Por otro lado, podrá conocer datos importantes pertenecientes a su control glucémico.

Costos e incentivos

Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad

Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Derechos del paciente

Si usted se siente incómodo durante la encuesta, podrá retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con el investigador Jean Pierre Camones Cabrera al número de teléfono: 943 573 848 o al comité que validó el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. +51 924 569 790. *E-mail*: comite.etica@uwiener.edu.pe

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo qué cosas pueden pasar si participo en el proyecto. También entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Nombre y Apellido:

DNI:

Firma: -----

ANEXO 5: TEST DE SIMILITUD

Similarity Report	
PAPER NAME	AUTHOR
"ESTILO DE VIDA Y CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II DEL CENTRO DE SALUD S	JEAN PIERRE GUSTAVO CAMONES CABRERA
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
11844 Words	63107 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
58 Pages	151.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Aug 28, 2024 11:44 AM GMT-5	Aug 28, 2024 11:46 AM GMT-5
● 14% Overall Similarity	
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.	
• 11% Internet database • 5% Publications database • Crossref database • Crossref Posted Content database • 10% Submitted Works database	
● Excluded from Similarity Report	
• Bibliographic material • Quoted material • Cited material • Small Matches (Less than 10 words) • Manually excluded text blocks	

ANEXO 7: FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

ALFA DE CRONBACH - CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA (IMEVID)

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,889	25

*Análisis realizado en el software SPSS versión 25.